Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Fausse route / Obstruction des voies aériennes

Adulte, enfant (IME), troubles de déglutition (MAS, FAM, EHPAD)

15 IMMÉDIAT · ne peut plus parler, tousser ni respirer, mains à la gorge, lèvres bleues, perte de connaissance ; **désobstruction réussie : appeler quand même** ; gêne persistante, SpO2 < 90 %.

Toux efficace ou non ?

- Tousse fort, parle, crie, pleure, respire : **obstruction partielle**.
- Ne peut plus parler, tousser ni respirer, devient bleu : **obstruction complète**.
- Ne parle pas : arrêt brutal du repas, agitation, regard paniqué, bruit respiratoire.

Je ne fais pas

- Mettre les doigts dans la bouche **à l'aveugle**.
- Donner à boire pour « faire passer » ; allonger une personne qui respire mal.
- Reprendre le repas après un épisode sévère sans avis de l'IDE.
- Modifier de moi-même la texture prescrite (eau gélifiée, mixé).

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Arrêter** le repas ; rester ; appeler à l'aide (complète : un collègue **appelle le 15**). Fauteuil : freins.
2. Partielle : l'**encourager à tousser**, l'installer au mieux, surveiller.
3. Complète : **1 à 5 claques** vigoureuses entre les omoplates, penchée en avant.
4. Sans effet : **1 à 5 compressions abdominales** (creux de l'estomac) ; alterner les deux.
5. Enceinte, obèse, alitée ou impossible à encercler : **compressions thoraciques**.
6. Perd connaissance : au sol, **RCP** ; à chaque cycle, retirer l'objet s'il est visible.

ENSUITE

7. Texture prescrite respectée (eau gélifiée, mixé) ? Troubles de déglutition connus ?

Enfant (IME)

- mêmes gestes, sauveteur à genoux

Nourrisson

- compressions **thoraciques**

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute** fausse route, même résolue par la toux.
- Toux au repas répétée, voix « mouillée », fièvre ou encombrement après un repas.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Heure, aliment, texture servie, gestes faits, résultat, qui a été prévenu.
- Jours suivants : toux, fièvre, encombrement, SpO2 < 90 % → IDE (infection pulmonaire possible).
- Signaler pour réévaluer déglutition et texture (médecin, orthophoniste).

À retenir : Toux efficace : laisser tousser. Toux inefficace : claques puis compressions, sans attendre. Après toute désobstruction : avis médical.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : ERC Guidelines 2025 First Aid et Adult Basic Life Support (Resuscitation 2025;215) ; Resuscitation Council UK, First Aid Guidelines (27/10/2025) ; DGSCGC, recommandations PSC1, fiches obstruction et désobstruction (12/2023).

Réf. DOTR-AS-FR | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature